

Sygnaly, *plan*, *działanie*

Bez planu profilaktyki nawrót następuje stopniowo i niezauważenie. Z planem — łapiesz objawy wcześniej i wracasz do ERP.

CZAS: 30 min + aktualizacje co 3–6 mies. Pod koniec formalnej terapii

ŹRÓDŁO: Hiss, Foa i Kozak (1994, RCT); McKay i wsp. (2015); Simpson (2004 — odstawienie SSRI)

JAK UŻYWAĆ

Stwórz **lista 5 sygnałów** ostrzegawczych: czas na rytuały, unikanie, nowe tematy, zapewnienie, stresor. Zapisz **top 5 strategii**, które działały najlepiej w terapii. **Plan awaryjny:** pierwsze sygnały → codzienne ERP; narastanie > 2 tyg. → sesja odświeżająca; *nie wracaj* do kompulsji „tylko na chwilę”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Plan profilaktyki nawrotów (ang. *relapse prevention*; Hiss, Foa i Kozak, 1994, RCT) **formalnie szkolony** redukuje wskaźnik nawrotów OCD. Bez profilaktyki: po samym CBT 20–30% nawrotów, po samym SSRI po odstawieniu 50–70% (Simpson, 2004). Po terapii pacjent czuje się dobrze i **porzuca codzienne ćwiczenia**. Stresor (przeprowadzka, choroba, nowe dziecko) reaktywuje OCD; w międzyczasie wkrada się „*ciche unikanie*” i mikrosprawdzanie. Bez planu nawrót następuje *stopniowo* i rozpoznany jest dopiero w pełnym objawowym kryzysie. Mechanizm planu: **identyfikacja wczesnych sygnałów** + skrypt awaryjny + okresowe boostery + samowspółczucie („*nawrót to okazja, nie porażka*”). NICE CG31 (2005): integralna część protokołu ERP.

01 ? Pięć sygnałów ostrzegawczych

1 · WZROST CZASU NA RYTUAŁY

„Sprawdzanie wraca, mycie się wydłuża”. **Mierzalna zmiana** — minuty lub liczba powtórzeń. Najwcześniejszy sygnał.

2 · POWRÓT UNIKANIA

„Już nie jeżdżę tą trasą”, „nie chodzę do tej kawiarni”. **Ciche unikanie** — wkrada się jako „preferencja”.

3 · NOWE TEMATY OBSESJI

OCD *zmienia temat* — z kontaminacji na sprawdzanie, ze sprawdzania na intruzje. **Metoda ta sama**, treść inna.

4 · WZROST SZUKANIA ZAPEWNIENIA

Pytasz bliskich częściej. Googlujesz. Wracają „czy to jest...?”, „czy mogę...?”. **Klasyczny zwiastun**.

5 · STRESOR ŻYCIOWY

Przeprowadzka, choroba, nowe dziecko, utrata pracy, ślub, awans. **Stres aktywuje stary szlak OCD** — uprzedź.

02 ☉ Plan awaryjny — trzy poziomy

POZIOM 1 SYGNAŁY

Pierwsze 1–2 sygnały → **wrót do codziennych ćwiczeń ERP**. 30 min/dzień, hierarchia z terapii. Zwykle wystarcza.

POZIOM 2 2+ TYG.

Objawy narastają > 2 tyg. → **umów sesję „odświeżającą”** z terapeutą. 1–3 sesje aktywują ślad bezpieczeństwa.

PUŁAPKA

NIE WRACAJ do kompulsji „tylko na chwilę”. Każdy taki krok cofa Cię tygodniami. Nawrót to *okazja*, nie porażka.

03 Mój osobisty plan profilaktyki

MOJE TOP 5 STRATEGII Z TERAPII

— co działało najlepiej

MOJE KONKRETNE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE	CO ZROBIĘ, GDY JE ZAUWAŻĘ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

04 Praktyka podtrzymująca

Mini-ekspozycje 1-2x tygodniowo — nawet gdy czujesz się dobrze. To trening utrzymujący „formę”.

Sesje odświeżające co 3-6 mies. — nawet bez objawów. Booster sesje aktywują uczenie inhibicyjne.

SSRI — nie odstawiaj bez konsultacji. NICE: minimum 12 mies. po remisji, odstawianie stopniowe.

Grupa wsparcia — kontakt z innymi pacjentami w remisji. Normalizacja „fal” i przypominanie strategii.

Klucz: Hiss, Foa i Kozak (1994, RCT): pacjenci z formalnym szkoleniem profilaktyki nawrotów osiągnęli **2x niższy** wskaźnik nawrotów w ciągu 6 miesięcy po terapii niż grupa bez planu. McKay i wsp. (2015): mechanizm = *wczesne wykrycie + szybka reakcja*. Klucz emocjonalny: nawrót **nie jest porażką** — to *normalny element* zaburzenia chronicznego. „OCD wraca, gdy stres się zwiększa — to nie znaczy, że terapia nie zadziałała”. Aktualizuj plan **co 3-6 mies.** — sygnały mogą się zmieniać, treści obsesji mogą ewoluować. Łącz z *utrzymaniem postępów*.